

地域医療

令和7年12月定例会 | 該当テーマの発言のみを収録。質問・答弁・再質問の順序と文言を維持しています。

この資料は正式会議録から「地域医療」に関する発言をテーマ別に抜粋したものです。省略部分は他テーマの発言です。

○10番（崎尾亮介）【登壇】

まず、地域医療について質問します。全国的に見ると、病院の施設数や病床数は減少傾向にあり、病院全体に占める公立公的病院の比率も年々低下していると報告されています。病院の統廃合、機能集約は今後も避けられない流れであり、地方の中小公立病院が姿を消し、その役割を限られた中核病院が担う構図が強まっています。大分県内を見ても、県北部医療圏の中核である中津市立中津市民病院では、救急専用病棟の整備や救急科の新設を経て、令和7年4月に県北部で初めての地域救命救急センター第三次救急医療機関の指定を受けました。24時間体制で重症かつ複数診療科にまたがる救急患者を受け入れる体制が整備され、県北部における三次救急の受皿が新たに構築されたところです。一方で、西部医療圏唯一の地域中核病院である済生会日田病院を中心とした日田市の医療提供体制は、医師偏在と機能縮小の両面で厳しさを増しています。大分県の医師確保計画によれば、西部医療圏は県内で唯一、医師少数区域とされ、少数科、産婦人科医の不足など診療科の偏在も課題と指摘されています。実際に済生会日田病院では、老朽化した放射線治療装置の更新ができず、令和6年9月から放射線治療の提供を中止し、がん患者さんは久留米市などの県外の連携病院で治療を受けざるを得ない状況となりました。また、日田市内で分娩を担ってきた産科診療所では、少子化と分娩数の減少を背景に、令和6年度中に入院病床を減らす計画が進められており、地域の産科医療提供能力は縮小傾向にあります。こうした中で西部医療圏の中核を担う済生会日田病院は、二次救急医療機関であると同時に地域がん診療病院、災害拠点病院、僻地医療拠点病院、感染症指定医療機関など多くの公的機能を一手に引き受けてきましたが、厳しい経営状況が続いていると報じられています。この厳しい経営状況を受けて、済生会日田病院では、経営分析や経営改善計画の策定、実行支援を外部の経営コンサルタントに委託する経営改善支援業務を新たに契約し、令和8年4月までの期間で集中的な立て直しを図ろうとしています。日田市もまた、西部医療圏を代表してこの経営改善会議に参画し、病院経営の健全化に責任を持って関わる体制について協議を進めていると説明しています。しかし、経営改善の名の下に、救急、がん医療、小児、産科、僻地、災害、感染症など西部医療圏にとって不可欠な機能が削減、撤退されれば、日田市と西部医療圏全体の医療水準はさらなる後退を余儀なくされます。中津市民病院に三次救急が新設される一方で、西部医療圏におけるがん治療や産科医療の体制が縮小していく現状を見れば、病院の数字だけが改善し、地域に必要な医療が失われるという本末転倒のリスクを直視せざるを得ません。以上のような全国的な公立公的病院の再編の流れ、大分県内他地域における中核病院機能の強化、西部医療圏における医師不足と医療機能の縮小、そして済生会日田病院の経営改善に市が関与し始めたという現状を踏まえ、日田市として地域医療をどう守るのか、地域中核病院をどう位置づけ、どのようなスキームと覚悟で支えるのか明らかにする必要があると考え、以下、質問いたします。市民が安心安全に暮らしていくための医療資源として、日田市の地域中核病院では、共同利用型二次救急や災害拠点、がん拠点などの機能を有していますが、市が考える守るべき医療について伺います。2つ目に、現在、市が地域中核病院の経営改善を一緒になって議論していますが、経営改善を優先するあまり、必要な医療資源がなくなってしまうのは、地域医療が後退してしまうのではないかと懸念があります。地域中核病院の持つ機能として、共同利用型や災害、がん拠点などのいわゆる不採算部門についてどういった議論を行っているのか伺います。

○福祉保健部長（河野健資）【登壇】

おはようございます。私からは、地域医療についてお答えをいたします。初めに、確保すべき医療体制についてでございます。

○福祉保健部長（河野健資）【登壇】

まず、医療制度における国、都道府県、市町村それぞれの行政の役割分担につきましては、国が医療提供体制の確保に関する基本方針や、それを踏まえた医療計画の枠組み、診療報酬制度の設計などを行い、都道府県が国の基本方針を踏まえ、地域の実情に応じた地域医療構想や地域医療計画を策定し、国と都道府県の負担により創設されました地域医療介護総合確保基金を活用しながら、その取組を推進し、市町村としましては、国や都道府県等と連携し、初期救急医療体制の整備など市町村単位の医療体制の確保を図ることが基本となっております。議員御案内のとおりですけれども、本市の地域中核病院は、西部医療圏唯一の中核病院として、二次救急、災害拠点、僻地医療など多岐にわたる機能を担っており、いずれの機能も西部医療圏の地域医療を確保する上では不可欠なものと考えております。本市といたしましても、こうした地域中核病院が担っ

ている全ての機能が可能な限り維持をされ、守られることが望ましいと考えております。他方で、こうした他の医療機関では担えない機能を一手に担っていることが、現在の厳しい経営状況にもつながっているものと認識をしております。このため、こうした機能について、将来的な維持が可能かどうかという観点も重要であることから、現在病院が進めている経営健全化に向けた議論の中で、こうした観点も踏まえて持続可能な機能が整理をされていくべきものと捉えております。

○福祉保健部長（河野健資）【登壇】

次に、地域中核病院の役割と存続の必要性についてでございます。本市の地域中核病院では、本年3月に経営改善会議を設置し、本市からの財政支援も受けながら、医療機関の経営面で専門的な知見を有するコンサルタント事業者を活用し、業務効率化など収支改善に向けた短期的な取組や病床機能などの最適化といった中長期的な取組を整理をしており、今後、経営改善に向けた基本的な方針を取りまとめることとしております。なお、取りまとめに当たりましては、病院内部での検討にとどまらず、大分県、医師会、済生会、そして本市を含む構成市町による4者協議における意見も十分踏まえながら決定をしていくこととしております。こうした中で、本年6月と8月に開催をされました4者協議の場において、西部医療圏における地域医療の課題について議論が行われたところですが、現状、多くの救急患者を受け入れていることを踏まえると、今後も二次救急医療体制は維持していくべきといった御意見や、救急医療体制も含め小児科と婦人科についても、現在の体制を維持してもらいたいなどの意見も示されたところでございます。このため本市としましては、こうした機能が単に不採算部門という理由のみで廃止するとの判断には至らない方向で議論が進められているものと捉えております。一方で、本市の地域中核病院が将来にわたって地域の医療を支えていくためには、経営の健全化は避けては通れない課題でございます。したがって、本市といたしましては、今後、西部医療圏としてどの機能が維持されるべきかについては、行政の役割分担を踏まえ、市民が安心して医療を受けられるよう、現在、経営改善会議で検討が進められている具体的な経営改善策による効果や収益の改善見込み等も慎重に見極めながら、議論に参画してまいりたいと考えております。私からは以上でございます。

○10番（崎尾亮介）まず、地域医療についてお伺いいたします。【再質問】

先日、今井議員の質問でもありましたが、がんの治療として放射線治療が地域中核病院からなくなり、それを受けるための市外の病院への通院が余儀なくされている現状があります。病気については、治療から経過観察等、連続した関わりが必要であると思いますが、市の見解をお伺いします。

○福祉保健部長（河野健資）お答えをいたします。【答弁】

昨日、御答弁させていただいたとおりでございますが、現在、地域中核病院においては、昨年9月より放射線治療を休止しており、市民の方が放射線治療を受けるため市外の医療機関を受診せざるを得ない現状については、本市としても認識をしているところでございます。その後の状況につきまして、地域中核病院に確認をいたしましたところ、がん治療におきましては、化学療法や手術など病院で実施可能な治療は引き続き提供しながら、放射線治療が必要な患者については、他の提携先の医療機関を紹介しているということと、放射線治療を休止した後も週1日、提携先の久留米大学の放射線治療の専門医の派遣を受けてフォローを継続しているということ。あとは、放射線治療が終了した患者については、これまでどおり地域中核病院のほうで経過観察を行いながら、継続的な治療を行っているということでした。こうしたことから、地域中核病院におきましては、今回経営上の苦渋の判断により放射線治療を休止している中、患者の方には御不便をおかけしているものの、可能な限り患者に寄り添って御対応いただいていると捉えており、治療から経過観察まで、一定程度連続した関わりに配慮をいただいているものというふうに捉えております。

こうしたがんに限らず多くの疾病におきまして、継続的な支援が必要となるケースは当然あり得るものと承知をしております。地域医療基幹病院においては、患者の状態に応じた適切な医療が受けられるよう、適切に御対応いただいているものとは承知をしておりますが、本市としては引き続き、こうした状況についてはよく目配りをしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。

○10番（崎尾亮介）【再質問】

承知いたしました。今回、放射線治療機器が日田市において使えなくなったということでございますが、一部の機能がなくなったと僕では思っているところです。今回、県北部では三次救急が始まって、医療における地域格差がちょっと僕が目についたように思っております。先ほどの答弁であれば、国、県、市がそれぞれ役割を果たしているというような内容の答弁だったと思うんですけれども、安心安全の根幹に関わるものだと僕は思っているもので、市の認識があればお聞かせください。

○福祉保健部長（河野健資） お答えをいたします。【答弁】

先ほど答弁で申し上げましたとおり、国と県と市それぞれの役割分担を踏まえまして、今後、4者協議の場において引き続き議論を重ねて、済生会病院経営が厳しい中で、どうした機能を今後整理されるべきかというのは、引き続き議論してまいりたいというふうに考えております。

○10番（崎尾亮介） 【再質問】

先ほどの4者協議の話ございましたけど、登壇でも申し上げましたが、現在、地域中核病院の経営改善を一緒に行っており、その中で地域中核病院が救急、がん医療などの不採算部門を担っていただいていると。これらは必要でありというような答弁だったと思うんですけど、地域中核病院が今後も担っていくという方向性でお話をされているのかを再度お伺いします。

○福祉保健部長（河野健資） お答えをいたします。【答弁】

先ほど御答弁をさせていただいたとおり、本市といたしましては、今重要な機能をかなり中核病院のほうで担っておりまして、こうした機能が、当然今後も継続していくことが望ましいとは考えていますものの、やはり今後、持続可能性という観点で、経営の問題というのいろいろな考えなくてはいけないと思っておりますので、まだ方向性というものはまだ見定まっているわけではございませんが、引き続き経営改善会議や4者協議の場で議論してまいりたいと考えております。

○10番（崎尾亮介） 【再質問】

現在、日田市が済生会病院に対して行っている補助金、救急小児医療等に係るものについて、そのうち特別交付税措置の算定対象として総務省に報告しているものをお伺いいたします。

○福祉保健部長（河野健資） お答えをいたします。【答弁】

本市におきまして、現在、済生会日田病院に対しましては、2つの事業に対して補助をしているところでございます。1つ目が、共同利用型病院運営事業に対する補助金で、今年度当初予算において約3,000万円を計上しており、2つ目が、小児救急医療支援事業に対する補助金であり、今年度当初予算において495万円程度の予算を計上しているところでございます。これらの事業につきましては、いずれも公的病院に対する運営補助として特別交付税の算定対象となっており、総務省への報告もしており、この報告を踏まえ、特別交付税が措置をされているものと承知をしております。

○10番（崎尾亮介） 【再質問】

済生会日田病院は地域中核病院であり、地域になくてはならない医療を守っていることから、名実ともに公的病院であると思っております。市民にとっても非常に重要な病院であるため、まず病院が継続していけるような取組が必要であると考えております。総務省の病院事業の地方財政措置の公的病院に対する特別交付税措置によりますと、今示していただいたもの以外にも存在するように承知しております。それらを踏まえ、他自治体では公的病院等に対する公的病院等運営費補助交付要綱のようなものを整備し、その補助を根拠に特別交付税措置を受けている例がありますが、日田市として再済生会日田病院を対象とした運営費補助の仕組み、要綱を新たに整備し、特別交付税措置を最大限活用する考えはあるのか、また、今後それを協議していく姿勢はあるのかお伺いいたします。

○福祉保健部長（河野健資） お答えをいたします。【答弁】

先ほど答弁申し上げましたとおり、済生会日田病院では、経営の改善に向けて、本年3月に西部医療圏の公的医療機関として果たすべき機能を精査しつつ、健全な経営を推進するため、経営改善会議を立ち上げ、本市もその構成員として参画をしているところでございます。本経営改善会議では、本年5月に本市からの財政支援を受けながら、医療機関の経営に関して専門的な知見を有するコンサルタント事業者と契約し、経営分析や経営改善計画の策定に着手をしているところでございます。現在、病床機能、病床数の適正化など地域医療を取り巻く状況を踏まえた抜本的な経営改善策についての検討を進めており、今後、来年3月頃、大分県、医師会、済生会及び構成市町によります4者協議における今後の西部医療圏における済生会日田病院の担う役割などについての議論も踏まえながら、最終的な方向性を取りまとめを行うこととしております。こうした中で本市としては、市民が安心して医療を受けられるよう、現在、経営改善会議で検討が進められております、具体的な経営改善策による効果や収益の修正見込み等も慎重に見極めた上で、財政支援の必要性の有無も含めて判断をすることとしたいと考えております。なお、仮に財政的な支援を行うこととなった場合には、特別交付税措置に加えて、活用可能なあらゆる財源を活用することが基本となるものと考えております。以上でございます。